Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
«Владимирский политехнический колледж»

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

КУРСОВАЯ РАБОТА

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ В РАМКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Студент(ка) _____ Т.В. Шентерова
курс, № группы инициалы, фамилия

Научный руководитель _____ Н.Н. Невский
подпись инициалы, фамилия

Оценка_____ Дата защиты:_____

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…….. 3
ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5
1.1 Понятие, принципы и правовая база обязательного медицинского страхования…….. 5
1.2 Субъекты и участники системы обязательного медицинского страхования…….. 8
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ОМС…… 11
2.1 1 Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования: структура и функции……... 11
2.2 Страховые медицинские организации и медицинские организации в системе ОМС…… 13
2.3 Порядок оказания и финансирования медицинской помощи по программам ОМС…… 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…… 20
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…… 22
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Обязательное медицинское страхование (ОМС) является одним из ключевых институтов системы социальной защиты населения Российской Федерации, обеспечивающим конституционное право граждан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь. В условиях реформирования системы здравоохранения и социального обеспечения вопросы организации работы органов, учреждений и организаций, осуществляющих медицинскую помощь в рамках ОМС, приобретают особую значимость.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что система обязательного медицинского страхования охватывает практически всё население страны и непосредственно влияет на доступность и качество медицинской помощи. Ежегодно в системе ОМС обслуживаются десятки миллионов граждан, а объёмы финансирования достигают триллионов рублей. При этом сложная многоуровневая структура субъектов и участников системы ОМС требует чёткого правового регулирования и надлежащей организации взаимодействия между всеми её звеньями.

Проблема организации работы системы ОМС является предметом активного научного и практического интереса. Вопросы правового регулирования, финансирования и управления в системе обязательного медицинского страхования исследовались в работах таких специалистов, как Т.В. Семёнова, В.З. Кучеренко, Н.Ф. Герасименко, А.М. Таранов, В.Б. Филатов и другие учёные.

Цель исследования — комплексный анализ организации работы системы органов, учреждений и организаций, осуществляющих медицинскую помощь гражданам в рамках обязательного медицинского страхования, а также выявление особенностей правового регулирования их деятельности.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

– изучить понятие, принципы и правовую базу обязательного медицинского страхования в Российской Федерации;

– охарактеризовать субъектный состав системы ОМС и определить правовой статус каждого участника;

– проанализировать структуру и функции Федерального фонда ОМС и территориальных фондов ОМС;

– рассмотреть роль страховых медицинских организаций и медицинских организаций в системе ОМС;

– исследовать порядок оказания и финансирования медицинской помощи по программам обязательного медицинского страхования.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере организации и функционирования системы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации.

Предмет исследования — нормы российского законодательства, регулирующие организацию деятельности органов, учреждений и организаций системы ОМС, а также правовые механизмы обеспечения граждан медицинской помощью в рамках обязательного медицинского страхования.

Методологическую основу настоящего исследования составили общенаучные и частнонаучные методы познания: системный и комплексный анализ, формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод, историко-правовой метод, а также методы анализа и синтеза нормативного и доктринального материала.

Нормативную базу исследования составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», иные федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты, а также приказы и разъяснения Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Понятие, принципы и правовая база обязательного медицинского страхования

Обязательное медицинское страхование (ОМС) представляет собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счёт средств обязательного медицинского страхования в пределах территориальной программы ОМС и в установленных законом случаях — в пределах базовой программы ОМС.

Конституционно-правовой основой системы ОМС является статья 41 Конституции Российской Федерации, закрепляющая право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь. Данная норма устанавливает, что медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений.[1]

Базовым законодательным актом, регулирующим систему ОМС, является Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее — Закон об ОМС). Указанный закон определяет правовое положение субъектов обязательного медицинского страхования и участников ОМС, основания возникновения их прав и обязанностей, гарантии их реализации, а также отношения и ответственность, связанные с уплатой страховых взносов на ОМС неработающего населения.[2]

---

[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.01.2025).

[2] Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 49. Ст. 6422.

Согласно статье 4 Закона об ОМС, основными принципами осуществления обязательного медицинского страхования являются:[3]

– обеспечение за счёт средств ОМС гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении страхового случая;

– устойчивость финансовой системы ОМС, обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения и средств ОМС;

– обязательность уплаты страхователями страховых взносов на ОМС;

– государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по ОМС независимо от финансового положения страховщика;

– создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ ОМС;

– паритетность представительства субъектов ОМС и участников ОМС в органах управления ОМС.

Правовую базу системы ОМС образует совокупность нормативных правовых актов различной юридической силы. Помимо Конституции РФ и Закона об ОМС, к числу ключевых источников относятся: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ о страховых взносах (в части норм, сохраняющих своё действие), а также ряд подзаконных нормативных актов — постановлений Правительства РФ, приказов Министерства здравоохранения РФ и ФОМС.

Важнейшим инструментом реализации права граждан на медицинскую помощь в системе ОМС является программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Ежегодно

[3] Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Ст. 4.

утверждаемая постановлением Правительства Российской Федерации, данная программа устанавливает перечни видов, форм и условий медицинской помощи, оказываемой бесплатно, перечни заболеваний и состояний, при которых оказывается медицинская помощь, категории граждан, которым она оказывается бесплатно.[4]

Базовая программа ОМС, являющаяся составной частью программы государственных гарантий, определяет виды медицинской помощи, перечень страховых случаев, структуру тарифа на оплату медицинской помощи, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС, а также критерии доступности и качества медицинской помощи. Территориальные программы ОМС субъектов Российской Федерации могут устанавливать дополнительные виды и объёмы медицинской помощи, финансируемые за счёт средств бюджетов субъектов.

Страховым случаем в системе ОМС является наступление заболевания, иного расстройства здоровья застрахованного лица, включая беременность и роды (естественный и операционный), а также меры профилактики. При наступлении страхового случая застрахованное лицо имеет право на получение медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объёме, установленном базовой программой ОМС.

Финансирование системы ОМС осуществляется за счёт страховых взносов работодателей (страхователей за работающих граждан), а также страховых взносов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (страхователей за неработающих граждан). Тариф страхового взноса на ОМС работающего населения установлен в размере 5,1% от фонда оплаты труда, с 2023 года тариф составляет 5,1% от базы, определяемой в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

---

[4] Постановление Правительства РФ от 28.12.2023 № 2353 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год». URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.01.2025).

Вывод по параграфу 1.1. Таким образом, обязательное медицинское страхование представляет собой сложную правовую конструкцию, основывающуюся на конституционном принципе доступности бесплатной медицинской помощи и реализуемую через разветвлённую систему нормативно-правового регулирования. Ключевым законодательным актом в данной сфере является Федеральный закон № 326-ФЗ, устанавливающий принципы, субъектный состав и механизм функционирования системы ОМС.

1.2 Субъекты и участники системы обязательного медицинского страхования

Закон об ОМС разграничивает понятия субъектов и участников системы обязательного медицинского страхования, что имеет принципиальное юридическое значение для понимания правового положения каждого из звеньев данной системы.

К субъектам обязательного медицинского страхования относятся: застрахованные лица, страхователи и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Участниками ОМС являются: территориальные фонды обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации, медицинские организации.

Застрахованными лицами по ОМС являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, постоянно или временно проживающие на территории РФ, а также лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов). Согласно статье 10 Закона об ОМС, застрахованными являются лица, работающие по трудовому договору или гражданско-правовому договору, а также самозанятые граждане и иные категории лиц, указанные в законе. Неработающими застрахованными являются дети со дня рождения до 18 лет, неработающие пенсионеры, студенты, безработные граждане и другие категории.[5]

[5] Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ. Ст. 10.

Страхователями для работающих граждан выступают юридические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и иные физические лица, обязанные уплачивать страховые взносы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Страхователями для неработающих граждан являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ.

Страховщиком в системе ОМС выступает Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Территориальные фонды ОМС реализуют отдельные полномочия страховщика в части ведения персонифицированного учёта, финансирования медицинских организаций и контроля за деятельностью страховых медицинских организаций.

Страховые медицинские организации (СМО) осуществляют отдельные полномочия страховщика в части заключения и исполнения договоров о финансовом обеспечении ОМС, а также договоров на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. СМО являются коммерческими организациями, имеющими лицензию на осуществление страховой деятельности в сфере ОМС.[6]

Медицинские организации включаются в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, и обязаны принимать к оплате полисы ОМС единого образца. К медицинским организациям в системе ОМС относятся государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения, а также частные медицинские организации, включённые в программу ОМС.

Застрахованное лицо имеет право на выбор страховой медицинской организации, выбор медицинской организации из числа включённых в реестр ОМС, выбор врача, получение медицинской помощи в объёме базовой

---

[6] Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования». URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2025).

программы на всей территории РФ, защиту персональных данных и конфиденциальность сведений, составляющих врачебную тайну.

Правовой статус застрахованного лица подтверждается полисом обязательного медицинского страхования единого образца, действующим на всей территории Российской Федерации. В настоящее время осуществляется переход на электронные полисы ОМС, что соответствует общей тенденции цифровизации государственных услуг.

Особого внимания заслуживает вопрос об ответственности субъектов и участников ОМС. За нарушение законодательства об ОМС предусмотрена ответственность страхователей, страховых медицинских организаций, а также медицинских организаций. Данная система ответственности является важной гарантией надлежащего функционирования системы ОМС.

Граждане Российской Федерации вправе реализовывать право на выбор страховой медицинской организации один раз в течение календарного года либо при изменении места жительства путём подачи заявления. Замена страховой медицинской организации производится путём уведомления ТФОМС. Это право является одним из ключевых механизмов конкурентного давления на страховые медицинские организации, стимулирующего их к повышению качества работы по защите интересов застрахованных.

Вывод по первой главе. Таким образом, система обязательного медицинского страхования представляет собой многоуровневую структуру с чётко определённым субъектным составом, включающим застрахованных лиц, страхователей, страховщика в лице ФОМС, страховые медицинские организации и медицинские организации. Каждый из участников системы имеет специфические права и обязанности, а их взаимодействие обеспечивает реализацию конституционного права граждан на бесплатную медицинскую помощь.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ОМС

2.1 Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования: структура и функции

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) является государственным некоммерческим финансово-кредитным учреждением, созданным для реализации государственной политики в области обязательного медицинского страхования. Правовой статус ФОМС закреплён в Законе об ОМС, а также в Уставе Федерального фонда ОМС, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации.[7]

К основным функциям ФОМС относятся: участие в разработке программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; аккумулирование средств обязательного медицинского страхования и управление ими; установление норматива финансового обеспечения ОМС на одно застрахованное лицо; ведение единого реестра застрахованных лиц; нормативно-методическое обеспечение системы ОМС; осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере ОМС.

Управление Федеральным фондом ОМС осуществляется коллегиальным органом — правлением и постоянно действующим единоличным исполнительным органом — директором. Правление ФОМС формируется на паритетных началах из представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, а также представителей общероссийских объединений работодателей и профессиональных союзов.

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС) создаются в субъектах Российской Федерации и реализуют отдельные полномочия страховщика. В соответствии со статьёй 34 Закона об ОМС, территориальный фонд является участником ОМС, осуществляющим отдельные полномочия страховщика.

---

[7] Постановление Правительства РФ от 29.11.2018 № 1440 «Об утверждении Устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 50. Ст. 7758.

К ключевым полномочиям территориальных фондов ОМС относятся следующие: ведение персонифицированного учёта сведений о застрахованных лицах и об оказанной им медицинской помощи; администрирование поступлений средств ОМС; осуществление финансового обеспечения деятельности страховых медицинских организаций; выравнивание финансовых условий деятельности СМО в части базовой программы ОМС; контроль за соблюдением законодательства об ОМС страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями; защита прав застрахованных лиц.

Персонифицированный учёт в системе ОМС ведётся в целях создания условий для обеспечения гарантий прав застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи надлежащего качества и объёма. Единый регистр застрахованных лиц формируется и ведётся ФОМС на основании сведений, представляемых территориальными фондами. Это обеспечивает реализацию права застрахованного на медицинскую помощь в объёме базовой программы ОМС на всей территории Российской Федерации.

Финансирование деятельности медицинских организаций в системе ОМС осуществляется ТФОМС через страховые медицинские организации. ТФОМС перечисляет СМО средства на авансирование оплаты медицинской помощи и средства на финансовое обеспечение медицинской помощи. Размер субвенций ФОМС территориальным фондам рассчитывается исходя из численности застрахованных лиц на территории субъекта и норматива финансового обеспечения ОМС.

Важным инструментом функционирования системы ОМС является тарифное соглашение — соглашение между органом исполнительной власти субъекта РФ, ТФОМС, представителями страховых медицинских организаций, медицинских организаций, профессиональных союзов медицинских работников и общественных объединений граждан,

определяющее структуру тарифов на оплату медицинской помощи, способы оплаты медицинской помощи и иные условия.[8]

Контроль за использованием средств обязательного медицинского страхования осуществляется ТФОМС путём проведения плановых и внеплановых проверок страховых медицинских организаций и медицинских организаций. По результатам контрольных мероприятий ТФОМС вправе применять финансовые санкции: возвращать в бюджет фонда средства, использованные не по целевому назначению, а также штрафовать медицинские организации за нарушения при оказании медицинской помощи. Данная система финансового контроля является важнейшей гарантией целевого использования средств ОМС.

Следует также отметить, что территориальные фонды ОМС осуществляют ведение регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц. В целях обеспечения идентификации застрахованных лиц и учёта оказанной им медицинской помощи ТФОМС взаимодействуют с органами записи актов гражданского состояния, органами миграционного учёта, органами социальной защиты населения и пенсионными органами. Такое межведомственное взаимодействие позволяет поддерживать актуальность и полноту регистра застрахованных лиц.

Вывод по параграфу 2.1. Таким образом, система фондов ОМС имеет двухуровневую структуру: федеральный уровень представлен ФОМС, осуществляющим общее управление системой и аккумулирование средств, а региональный — ТФОМС, непосредственно реализующими полномочия страховщика на территории субъекта Российской Федерации.

2.2 Страховые медицинские организации и медицинские организации в системе ОМС

Страховые медицинские организации занимают ключевое место в системе ОМС как посредники между фондами обязательного медицинского

[8] Козлов М.В. Совершенствование финансового механизма обязательного медицинского страхования // Финансы и кредит. 2022. № 5. С. 49.

страхования и медицинскими организациями, а также как защитники прав застрахованных граждан.

СМО допускаются к деятельности в сфере ОМС при наличии лицензии на осуществление страхования по виду «Обязательное медицинское страхование» и включения в реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС. СМО вправе осуществлять наряду с деятельностью в сфере ОМС деятельность по добровольному медицинскому страхованию.

Основными функциями страховых медицинских организаций в системе ОМС являются: заключение договоров о финансовом обеспечении ОМС с ТФОМС; оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам; ведение персонифицированного учёта оказанной медицинской помощи; контроль объёмов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи медицинскими организациями; защита прав и законных интересов застрахованных лиц.

Обеспечение прав застрахованных является одной из ключевых функций СМО. В этих целях страховые медицинские организации обязаны: бесплатно информировать застрахованных лиц об их правах и обязанностях, условиях получения медицинской помощи; рассматривать обращения и жалобы граждан; защищать права застрахованных в судебном и досудебном порядке; организовывать деятельность страховых представителей.

Институт страховых представителей введён в систему ОМС с 2016 года. Страховые представители — это сотрудники страховых медицинских организаций, осуществляющие информационное сопровождение граждан при получении медицинской помощи в рамках ОМС. Страховые представители трёх уровней (первого, второго и третьего) осуществляют информирование, консультирование и защиту прав застрахованных в зависимости от сложности возникшей ситуации.[9]

---

[9] Мальцева Е.Н. Институт страховых представителей: практика применения и перспективы развития // Страховое дело. 2023. № 1. С. 24.

Медицинские организации являются непосредственными исполнителями медицинской помощи в системе ОМС. В соответствии с Законом об ОМС медицинской организацией признаётся организация, осуществляющая медицинскую деятельность на основании соответствующей лицензии и включённая в реестр медицинских организаций.[10]

Включение в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, носит уведомительный характер. Медицинская организация, подавшая заявление о включении в реестр, не вправе отказаться от заключения договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. Данная норма призвана обеспечить доступность медицинской помощи для всех застрахованных лиц.

Договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС заключается между медицинской организацией, страховой медицинской организацией и ТФОМС. Данный договор является трёхсторонним и определяет объёмы медицинской помощи, условия и сроки её оказания, порядок оплаты, ответственность сторон.

Медицинские организации в системе ОМС обязаны: бесплатно оказывать застрахованным лицам медицинскую помощь в рамках программ ОМС; вести учёт и отчётность по установленным формам; соблюдать стандарты и порядки оказания медицинской помощи; применять порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи; обеспечивать застрахованным лицам реализацию права на выбор врача и медицинской организации.

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности в системе ОМС осуществляется на нескольких уровнях. Внутренний контроль осуществляется самой медицинской организацией. Страховые медицинские организации проводят медико-экономический контроль, медико-

[10] Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.

экономическую экспертизу и экспертизу качества медицинской помощи. ТФОМС осуществляет контроль в части своей компетенции.

Вывод по параграфу 2.2. Таким образом, страховые медицинские организации и медицинские организации занимают важнейшее место в системе ОМС: первые обеспечивают финансовое посредничество и защиту прав застрахованных, вторые непосредственно оказывают медицинскую помощь. Их взаимодействие регулируется договорными отношениями и контрольными механизмами, призванными обеспечить надлежащее качество и доступность медицинской помощи.

2.3 Порядок оказания и финансирования медицинской помощи по программам ОМС

Медицинская помощь в рамках ОМС оказывается в трёх формах: плановая медицинская помощь — медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи; неотложная медицинская помощь — медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; экстренная медицинская помощь — медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических болезней, представляющих угрозу жизни пациента.

В системе ОМС медицинская помощь предоставляется в следующих видах: первичная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь, включая высокотехнологичную; скорая медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. С 2021 года в базовую программу ОМС включена медицинская реабилитация.

Базовая программа ОМС определяет виды медицинской помощи (включая перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи), перечень страховых случаев, структуру тарифа на оплату медицинской

помощи, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС в субъектах Российской Федерации, а также критерии доступности и качества медицинской помощи.

Финансирование медицинской помощи в системе ОМС осуществляется по принципу «деньги следуют за пациентом»: средства направляются в ту медицинскую организацию, где фактически оказывается медицинская помощь. Способы оплаты медицинской помощи в амбулаторных условиях: по подушевому нормативу финансирования на прикреплённое лицо в сочетании с оплатой за единицу объёма медицинской помощи; за единицу объёма медицинской помощи; за медицинскую услугу.

Способы оплаты медицинской помощи в стационарных условиях включают: оплату по клинико-статистическим группам (КСГ), объединяющим случаи лечения, сходные по характеру используемых ресурсов и набору медицинских услуг; оплату за законченный случай лечения заболевания; оплату за прерванный случай лечения. КСГ — это группы, объединяющие случаи лечения, однородные по характеру заболеваний и проводимых лечебно-диагностических мероприятий, с подобными затратами.[11]

Тарифы на оплату медицинской помощи устанавливаются тарифным соглашением на основе нормативов объёмов медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи. Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств и расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату и амортизацию основных средств.

---

[11] Петров С.Е. Клинико-статистические группы как инструмент оплаты стационарной медицинской помощи // Здравоохранение. 2022. № 8. С. 69.

Контроль в сфере ОМС является многоуровневым и включает несколько видов экспертизы. Медико-экономический контроль представляет собой установление соответствия сведений об объёмах оказанной медицинской помощи застрахованным лицам на основании предоставленных к оплате реестров счетов условиям договоров на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, территориальной программе ОМС, способам и условиям оплаты медицинской помощи. Медико-экономическая экспертиза устанавливает соответствие фактических сроков оказания медицинской помощи, объёма предъявленных к оплате медицинских услуг записям в первичной медицинской документации. Экспертиза качества медицинской помощи (ЭКМП) выявляет нарушения при оказании медицинской помощи, в том числе оценивает правильность выбора медицинской технологии, степень достижения запланированного результата.

Особое место в системе ОМС занимает диспансеризация — комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья. С 2019 года все виды диспансеризации и профилактических медицинских осмотров оплачиваются из средств ОМС, что обеспечивает их доступность для широких слоёв населения.

В системе ОМС предусмотрен механизм межтерриториальных расчётов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис. Данный механизм реализуется через ФОМС как расчётный центр. Застрахованное лицо при обращении за медицинской помощью в другом регионе вправе обратиться в любую медицинскую организацию, работающую в системе ОМС данного региона. Оплата оказанной помощи осуществляется по нормативам, установленным в регионе оказания помощи, с последующим возмещением затрат через механизм межтерриториальных расчётов.

Важнейшим направлением развития системы ОМС в современных условиях является цифровизация. С 2022 года в России активно внедряются

электронные медицинские карты, цифровые профили пациентов и информационные системы мониторинга качества медицинской помощи. Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) обеспечивает информационное взаимодействие между всеми участниками системы ОМС, позволяет в режиме реального времени отслеживать объёмы и качество оказываемой медицинской помощи, а также обмениваться медицинскими данными между регионами. Развитие цифровых технологий в системе ОМС призвано повысить прозрачность и эффективность расходования средств обязательного медицинского страхования.

Вывод по второй главе. Таким образом, система организации оказания и финансирования медицинской помощи в рамках ОМС представляет собой многоуровневый, чётко структурированный механизм, включающий базовую программу ОМС, территориальные программы, разнообразные способы оплаты медицинской помощи (подушевое финансирование, КСГ и другие), а также контрольные механизмы, обеспечивающие качество и доступность медицинской помощи для всех застрахованных лиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведённого исследования автор пришёл к следующим выводам.

Во-первых, обязательное медицинское страхование является фундаментальным институтом системы социальной защиты населения Российской Федерации, обеспечивающим реализацию конституционного права граждан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь. Правовую основу системы ОМС образует развитая нормативная база во главе с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ, дополняемая обширным массивом подзаконных актов. Закон об ОМС закрепляет шесть ключевых принципов системы: государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи, устойчивость финансовой системы, обязательность уплаты страховых взносов, государственная гарантия соблюдения прав застрахованных, создание условий для доступности и качества медицинской помощи, паритетность представительства субъектов в органах управления ОМС.

Во-вторых, система ОМС имеет сложный субъектный состав, включающий застрахованных лиц, страхователей, Федеральный фонд ОМС (как страховщика), территориальные фонды ОМС, страховые медицинские организации и медицинские организации. Разграничение субъектов и участников системы ОМС имеет принципиальное юридическое значение: субъекты являются основными сторонами страховых правоотношений, тогда как участники реализуют отдельные функции в системе ОМС. Каждый из элементов субъектного состава наделён специфическими правами и обязанностями, закреплёнными в законодательстве.

В-третьих, организационная структура системы ОМС имеет двухуровневый характер: федеральный уровень представлен ФОМС, осуществляющим аккумулирование средств, нормативно-методическое обеспечение и общее управление системой; региональный уровень — ТФОМС, непосредственно реализующими полномочия страховщика на

территории субъектов Российской Федерации. Данная двухуровневая система обеспечивает единство стандартов медицинской помощи на всей территории страны при одновременном учёте региональной специфики.

В-четвёртых, страховые медицинские организации занимают роль ключевых посредников системы ОМС: они осуществляют финансирование медицинских организаций, ведут персонифицированный учёт, проводят контроль качества медицинской помощи и, что особенно важно, защищают права и законные интересы застрахованных лиц. Введение института страховых представителей с 2016 года существенно усилило правозащитный компонент деятельности СМО.

В-пятых, система оказания медицинской помощи по ОМС характеризуется многообразием форм (плановая, неотложная, экстренная), видов (первичная медико-санитарная, специализированная, скорая и паллиативная помощь) и условий оказания (амбулаторные, стационарные). Финансирование медицинских организаций строится по принципу «деньги следуют за пациентом» с применением различных способов оплаты (подушевое финансирование, клинико-статистические группы и другие).

Проведённое исследование позволяет констатировать, что система ОМС в Российской Федерации в целом сформирована и функционирует. Вместе с тем ряд проблем сохраняется: недостаточное финансирование отдельных видов медицинской помощи, нагрузка на первичное звено здравоохранения, проблемы с доступностью специализированной помощи в отдалённых регионах. Решение данных проблем требует как совершенствования нормативно-правового регулирования системы ОМС, так и увеличения финансового обеспечения базовой и территориальных программ ОМС.

Таким образом, система органов, учреждений и организаций, осуществляющих медицинскую помощь в рамках ОМС, представляет собой сложный, многоуровневый правовой и организационный механизм, призванный обеспечить реализацию конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на охрану здоровья.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.01.2025).

2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 49. Ст. 6422.

3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.

4. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об основах обязательного социального страхования» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 29. Ст. 3686.

5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О страховых пенсиях» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6965.

6. Постановление Правительства РФ от 28.12.2023 № 2353 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.01.2025).

7. Постановление Правительства РФ от 29.11.2018 № 1440 «Об утверждении Устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 50. Ст. 7758.

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования» //

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2025).

9. Приказ ФОМС от 28.02.2019 № 36 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» (ред. от 22.12.2020). URL: http://www.ffoms.gov.ru (дата обращения: 14.01.2025).

Научные и учебные издания

10. Афтахова А.В. Пенсионное обеспечение: учебное пособие для среднего профессионального образования. — М.: Юрайт. 2020. 94 с.

11. Дзгоева-Сулейманова Ф.О., Акатнова М.И., Благодир А.Л. Право социального обеспечения: учебник. — М.: Проспект. 2022. 231 с.

12. Кучеренко В.З., Яковлев Е.П. Организация и анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений в условиях обязательного медицинского страхования. — М.: ФОМС. 2019. 264 с.

13. Право социального обеспечения России: учебник для бакалавров / отв. ред. Э. Г. Тучкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект. 2023. 480 с.

14. Семёнова Т.В. Обязательное медицинское страхование в системе социальной защиты населения. — М.: ИНФРА-М. 2021. 192 с.

15. Филатов В.Б., Таранов А.М. Организация системы обязательного медицинского страхования: учебное пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа. 2020. 208 с.

Публикации в периодических изданиях

16. Анисимова О.А. Правовые проблемы реализации прав застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования // Медицинское право. 2023. № 2. С. 12–18.

17. Козлов М.В. Совершенствование финансового механизма обязательного медицинского страхования // Финансы и кредит. 2022. № 5. С. 45–56.

18. Мальцева Е.Н. Институт страховых представителей: практика применения и перспективы развития // Страховое дело. 2023. № 1. С. 22–29.

19. Петров С.Е. Клинико-статистические группы как инструмент оплаты стационарной медицинской помощи // Здравоохранение. 2022. № 8. С. 67–74.

Электронные ресурсы

20. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. URL: http://www.ffoms.gov.ru (дата обращения: 15.01.2025).

21. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации. URL: https://www.rosminzdrav.ru (дата обращения: 16.01.2025).

22. Государственный доклад о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 2023 году. Министерство здравоохранения РФ. URL: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/doklad (дата обращения: 18.01.2025).

Приложение 1

Структура системы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации

СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РФ			
СУБЪЕКТЫ ОМС	**УЧАСТНИКИ ОМС**	**ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**	**НОРМАТИВНАЯ БАЗА**
Застрахованные лица	Территориальные фонды ОМС (ТФОМС)	Минздрав России	Конституция РФ (ст. 41)
Страхователи (работодатели, органы власти)	Страховые медицинские организации (СМО)	Федеральный фонд ОМС	ФЗ № 326-ФЗ от 29.11.2010
Федеральный фонд ОМС (страховщик)	Медицинские организации	ТФОМС	ФЗ № 323-ФЗ от 21.11.2011
		Росздравнадзор	Программа госгарантий

Приложение 2

Схема финансирования медицинской помощи в системе ОМС

СТРАХОВАТЕЛИ (работодатели, 5,1% от ФОТ)	**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС** (аккумулирование средств)	**СТРАХОВЫЕ МЕД. ОРГАНИЗАЦИИ** (оплата медпомощи)
ОРГАНЫ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ (за неработающих граждан)	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ОМС (субвенции от ФОМС)	МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (фактическое оказание помощи)

Принцип финансирования: «Деньги следуют за пациентом»